

PROY-NOM-045-SSA-2026

Marco Normativo General

Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones

Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) • Versión Completa

Gobierno de México • Vigente para Consulta Pública 2026

Contexto y Propósito de la Norma

Objetivo y Alineación de Estado

El propósito primario de la norma consiste en **reducir drásticamente la morbilidad, mortalidad y los altos costos** derivados de las infecciones intrahospitalarias.

Este marco se encuentra directamente coordinado con las directrices estratégicas de prevención del **Programa Sectorial de Salud 2025-2030**.

Transición Histórica Obligatoria

Sustituye por completo a la antigua **NOM-045-SSA2-2005**, eliminando su vacío normativo al integrar lineamientos explícitos para neonatos y lactantes.

Ámbito de aplicación: Todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud (públicos, sociales y privados), con especial obligatoriedad en unidades de cuidados intensivos, obstétricas y neonatales.

Cambio de Concepto

La transición terminológica representa un ajuste metodológico profundo: de un concepto meramente físico-espacial a uno de origen funcional y preventivo.

PARADIGMA ANTERIOR

Infección Nosocomial Limitada estrictamente a eventos dentro del perímetro físico del hospital.

ESTÁNDAR ACTUAL

Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) Cubre eventos ambulatoria, traslados médicos y cirugía mayor ambulatoria.

- 🕒 **Seguimiento extendido:** Puede manifestarse hasta **30-90 días después del egreso** del paciente (crítico para neonatos con cirugías o dispositivos).



Clasificación de Registro Obligatorio

Con el fin de mitigar errores epidemiológicos y garantizar datos precisos, se define la categorización obligatoria de cada proceso infeccioso en tres directrices rígidas:



IAAS de la Unidad

Infección contraída directamente en el establecimiento durante el internamiento del paciente o como resultado directo de una intervención médica local.



IAAS Importada

Proceso infeccioso activo presente al ingreso, pero que fue adquirido fehacientemente durante una estancia o procedimiento en otra unidad de salud.



Congénita / Perinatal

Patógeno transmitido por vía materna o ya presente de forma natural al momento del nacimiento. **No se contabiliza como IAAS** bajo ningún criterio.



Reconocimiento del Grupo de Riesgo

$\leq 1,500\text{g}$
PESO CRÍTICO DE CONTROL

Neonatos y Menores de 1 Año

Se establece normativamente por primera vez un espectro de protección diferenciada y medidas de bioseguridad especiales orientadas a los lactantes, particularmente los nacidos con **prematurez extrema**.

Este grupo representa la población hospitalaria de mayor susceptibilidad para el desarrollo de brotes sépticos, exigiendo metodologías de aislamiento y manipulación aséptica altamente restrictivas.

Factores de Vulnerabilidad Neonatal



¿Por qué requieren medidas diferenciadas?



Piel y Barreras Inmaduras: Dermis extremadamente delgada con nula capacidad de queratinización, altamente propensa a desgarros y entrada de patógenos.



Sistema Inmunario Débil: Desarrollo deficitario de anticuerpos y mecanismos fagocíticos, reduciendo la respuesta celular defensiva.



Exposición Invasiva Prolongada: Alta dependencia de accesos vasculares centrales, intubación endotraqueal y nutrición parenteral de larga duración.

Estructura Organizativa Obligatoria

La implementación del marco normativo delega responsabilidades estratégicas integradas por equipos clínicos técnicos y multidisciplinarios:



Comités COVEPCIAAS / COA

Integración técnica forzosa: No basta personal administrativo o general. Deben incluir neonatólogos, personal de enfermería especialista y nutriólogos de forma activa.



La Unidad UVEH

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria operará de manera autónoma, con personal dedicado exclusivamente y reforzado en proporción directa al número de camas.



Documentación POE

Estandarización absoluta: Obligatoriedad de redactar y verificar Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) adaptados de forma minuciosa para las áreas críticas neonatales.

Estandarización y Protocolos POE

Documentación Práctica y Legal

La norma exige que cada unidad de terapia neonatal u obstétrica mantenga manuales y **Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)** de actualización anual obligatoria.

Ningún tratamiento o inserción invasiva puede realizarse de manera discrecional; todo el personal clínico debe apegarse rigurosamente a las guías técnicas autorizadas.

Enfoque Preventivo: Incluye técnicas de lavado aséptico de manos, manejo estéril de catéteres venosos centrales y lineamientos de desinfección ambiental.





Articulación con Otras Normas Oficiales

La PROY-NOM-045-SSA-2026 no funciona en aislamiento; se vincula estrechamente y de manera transversal con el marco legal sanitario vigente en el país:

Clave de Norma	Enfoque Específico	Interacción y Sinergia Operativa
NOM-025-SSA3-2013	Cuidados Intensivos	Regula la infraestructura física, equipamiento tecnológico y la capacitación mínima del personal en UTIN.
NOM-007-SSA3-2011	Laboratorios Clínicos	Establece estándares para la toma rápida, transporte y procesamiento controlado de cultivos bacterianos.
Disposiciones Extra	Leche Humana y Agua	Regulación estricta para la pasteurización en bancos de leche y el monitoreo biológico de la calidad del agua de consumo clínico.

Evolución de la Norma

Anterior (NOM-045-SSA2-2005)

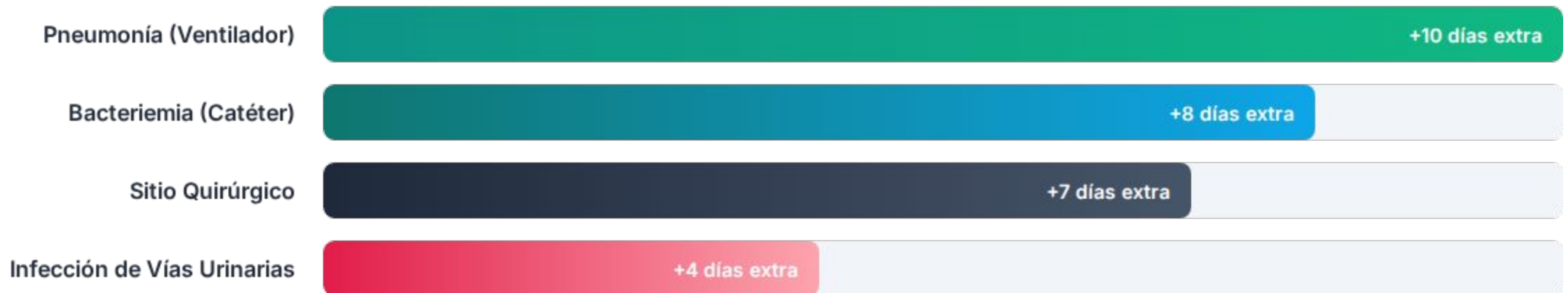
- El foco de acción se limitaba exclusivamente a lo acontecido en "unidades hospitalarias tradicionales".
- Carencia absoluta de un espectro protector y diferenciado para los recién nacidos o prematuros extremos.
- Comités institucionales con estructura general, sin exigir participación de subespecialistas específicos.

Actual (PROY-NOM-045-SSA-2026)

- Concepto dinámico e integral de IAAS; abarca entornos móviles, traslados y estancias ambulatorias.
- Integración formal de la vulnerabilidad pediátrica y neonatal, estableciendo lineamientos de peso clínico.
- Comités técnicos COVEPCIAAS con presencia obligatoria de neonatólogos y especialistas en nutrición clínica.

Prolongación de Estancia por IAAS

La presencia de IAAS en pacientes críticos incrementa notablemente la saturación del sistema y los días promedio de hospitalización adicional:



Nota: Los días adicionales incrementan de forma exponencial el riesgo de sobreinfecciones multidrogorresistentes y saturan la disponibilidad de camas en Terapias Intensivas Neonatales.